

眼科药物相互作用系统评估 — 专家评审问卷（第 1 页 / 共 2 页）

说明：每行一例 —— 眼科局部用药（滴眼液）× 全身用药（口服/注射）。【风险判断】= 您对该组合临床风险的个人判断；【认可度】= 对系统评估的认可程度（5=完全认可）。证据来源已注明（FDA 标签 / Stockley's / DDInter），供参考。

编号	药物组合	临床情境	系统评估与依据	风险判断	认可度
1	噻吗洛尔（滴眼液） × 阿替洛尔（口服）	65 岁男性，开角型青光眼，0.5% 噻吗洛尔滴眼液每日 2 次；因高血压口服阿替洛尔 25mg/日。复诊诉偶有头晕乏力，静息心率 52 次/分。	高 机制：噻吗洛尔滴眼液全身吸收可达 50-80%（经鼻泪管入血、绕过首过代谢），与全身 β 受体阻滞剂叠加负性变时效应 → 明显心动过缓。 建议：监测心率/血压，必要时换用前列腺素类似物等全身影响小的降眼压药。 证据：FDA Timoptic 标签明确警示“additive effects of beta blockade”；Stockley's Drug Interactions 患者提示：老年患者心率储备低， β 叠加效应更明显，应主动问诊头晕/乏力。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
2	溴莫尼定（滴眼液） × 芬太尼（静脉/透皮）	72 岁女性，青光眼，滴用溴莫尼定；因膝关节置换术后疼痛使用芬太尼镇痛。家属诉患者白天嗜睡明显，血压偏低。	高 机制：溴莫尼定（ $\alpha 2$ 激动剂）全身吸收约 10-50%，本身可引起中枢抑制（嗜睡、低血压、儿童呼吸抑制）；与阿片类中枢抑制叠加，老年患者风险更高。 建议：监测意识状态与血压，避免夜间加用镇静药。 证据：FDA Alphagan P 标签 CNS depression 警示： $\alpha 2$ 激动剂类效应 患者提示：老年 + 术后状态，嗜睡增加跌倒风险，应嘱家属观察。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
3	阿托品（滴眼液） × 阿米替林（口服）	58 岁男性，虹膜睫状体炎，1% 阿托品滴眼液；因抑郁症口服阿米替林 75mg/日。用药 1 周后出现排尿困难、口干、轻度意识模糊。	高 机制：阿托品滴眼液全身吸收高（>50%），与三环类抗抑郁药（强抗胆碱）叠加 → 外周（尿潴留、便秘）与中枢（谵妄）抗胆碱综合征。 建议：避免合用或密切监测；必要时换用无抗胆碱活性的抗抑郁药。 证据：FDA 阿托品标签抗胆碱警示；Stockley's 抗胆碱药叠加章节 患者提示：老年男性合并前列腺增生者，尿潴留风险显著升高。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
4	多佐胺（滴眼液） × 氢氯噻嗪（口服）	60 岁女性，青光眼，2% 多佐胺滴眼液；因高血压口服氢氯噻嗪 12.5mg/日。化验示血钾 3.3mmol/L，碳酸氢根轻度下降。	中 机制：多佐胺（碳酸酐酶抑制剂）与噻嗪类利尿剂均可致代谢性酸中毒与低钾，合用风险叠加（尤其肾功能不全者）。 建议：监测电解质/酸碱平衡，必要时补钾。 证据：FDA Trusopt 标签“additive effects with oral carbonic anhydrase inhibitors”；DDInter Moderate 患者提示：肾功能不全、低钾饮食者电解质风险更高。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
5	酮咯酸（滴眼液） × 华法林（口服）	68 岁男性，白内障术后炎症，酮咯酸滴眼液；因房颤长期口服华法林（INR 2.2）。	中 机制：酮咯酸（NSAID）滴眼液有少量全身吸收（<10%），抑制血小板 + 华法林抗凝 → 出血风险增加（胃肠道、眼内）。 建议：监测 INR 与出血征象，避免长期使用；与抗凝患者沟通。 证据：FDA Acular 标签“caution with anticoagulants”；DDInter Major（全身途径评级，眼科剂量修正为中） 患者提示：INR 目标 2-3，合用期间可适当增加监测频率。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
6	倍他洛尔（滴眼液） × 美托洛尔（口服）	70 岁女性，青光眼，0.25% 倍他洛尔滴眼液；因冠心病口服美托洛尔 47.5mg/日。静息心率 55 次/分，无不适。	中 机制：倍他洛尔（ $\beta 1$ 选择性，全身吸收中等 10-50%）与全身 β 阻滞剂存在叠加负性变时效应，但程度较轻。 建议：监测心率即可，一般无需停药。 证据：FDA Betoptic 标签 additive beta-blockade 警示：DDInter Moderate 患者提示：心率 <50 次/分或出现症状时应重新评估。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

标注含义：高=建议规避或严格监测；中=需监测或调整；低=眼科剂量下风险可忽略。意见请写在表格空白处。

眼科药物相互作用系统评估 — 专家评审问卷（第 2 页 / 共 2 页）

说明：每行一例 —— 眼科局部用药（滴眼液）× 全身用药（口服/注射）。【风险判断】= 您对该组合临床风险的个人判断；【认可度】= 对系统评估的认可程度（5=完全认可）。证据来源已注明（FDA 标签 / Stockley’s / DDInter），供参考。

编号	药物组合	临床情境	系统评估与依据	风险判断	认可度
7	拉坦前列素（滴眼液） × 阿替洛尔（口服）	63 岁男性，开角型青光眼，拉坦前列素滴眼液；因高血压口服阿替洛尔。无特殊不适。	低 机制：前列腺素类似物全身吸收极低（<1%），与 β 阻滞剂无已知药理学相互作用。 建议：无需特殊处理。 证据：FDA Xalatan 标签无系统相互作用记录 患者提示：无特殊。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
8	拉坦前列素（滴眼液） × 美托洛尔（口服）	66 岁女性，青光眼，拉坦前列素；因心衰口服美托洛尔。病情平稳。	低 机制：前列腺素类似物全身暴露极低，无已知与 β 阻滞剂相互作用。 建议：无需特殊处理。 证据：FDA Xalatan 标签；DDInter 无眼科相关记录 患者提示：无特殊。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
9	拉坦前列素（滴眼液） × 普萘洛尔（口服）	55 岁男性，青光眼，拉坦前列素；因偏头痛预防口服普萘洛尔。无不适。	低 机制：无已知相互作用机制（前列腺素类不干扰 β 通路）。 建议：无需特殊处理。 证据：FDA Xalatan 标签 患者提示：无特殊。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
10	噻吗洛尔（滴眼液） × 美托洛尔（口服）	71 岁男性，青光眼，0.5% 噻吗洛尔滴眼液；因心衰口服美托洛尔 95mg/日。诉活动后气短乏力，静息心率 48 次/分。	高 机制：噻吗洛尔高全身吸收 + 全身 β 阻滞剂叠加 → 显著心动过缓、心衰代偿受损（本例心率 48 已有表现）。 建议：监测心率/心功能，考虑换用前列腺素类似物或溴莫尼定替代。 证据：FDA Timoptic 标签；DDInter（timolol 全身评级高，眼科高吸收适用） 患者提示：心衰患者代偿储备低，心率下降可能诱发失代偿。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
11	溴莫尼定（滴眼液） × 吗啡（口服）	74 岁女性，青光眼，溴莫尼定滴眼液；因带状疱疹后神经痛口服吗啡缓释片。家属诉白天嗜睡明显。	高 机制：溴莫尼定中枢抑制与阿片类叠加（老年患者尤其明显），可致明显嗜睡、低血压，跌倒风险增加。 建议：监测意识状态，谨慎合用；告知家属观察。 证据：FDA Alphagan P 标签 CNS 警示：阿片类中枢抑制类效应 患者提示：老年患者跌倒风险高，应嘱家属观察意识状态。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐
12	阿托品（滴眼液） × 苯海拉明（口服）	45 岁女性，葡萄膜炎，1% 阿托品滴眼液；因过敏性鼻炎口服苯海拉明。诉口干、视物模糊加重、便秘。	中 机制：阿托品（高全身吸收）与苯海拉明（抗组胺，具抗胆碱活性）抗胆碱作用叠加 → 口干、便秘、尿潴留、谵妄风险。 建议：关注抗胆碱症状，可换用无抗胆碱活性的抗组胺药（如氯雷他定）。 证据：FDA 阿托品标签；抗胆碱类效应 患者提示：老年患者抗胆碱效应更敏感，警惕谵妄。	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

标注含义：高=建议规避或严格监测；中=需监测或调整；低=眼科剂量下风险可忽略。意见请写在表格空白处。